



**Étude épidémiologique de l'hypertension artérielle  
allant de février à mars 2026 (Enquête menées à  
Caradeux et Delmas 60)**

**Travail de recherche préparé par le groupe 1**

## Dédicaces et remerciements

<<.L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde.  
>> Nelson Mandela

Nous dédions ce devoir de recherche à toutes les personnes touchées par l'hypertension artérielle, ainsi qu'à celles qui œuvrent pour leur bien-être.

Nous exprimons notre profonde gratitude :

- À Dieu, pour nous avoir guidés et soutenus tout au long de ce parcours.
- À notre professeur **Dr Morisset Love Kervens** pour votre savoir partagé, votre patience et votre encadrement précieux. Votre passion pour la médecine et votre dévouement ont grandement contribué à notre épanouissement académique et à la réalisation de ce travail.
- À notre groupe composé de huit personnes pour leur collaboration, leur solidarité et notre engagement envers ce sujet crucial.
- À tous ceux qui, par leur savoir et leur engagement, contribuent à l'amélioration de la santé publique.
- À la population haïtienne, dont la résilience et la détermination face aux défis sanitaires nous ont inspiré tout au long de ce travail.

Que ce devoir de recherche soit une contribution significative à la sensibilisation et à la compréhension de l'hypertension artérielle.

## Liste des abréviations

HTA : Hypertension artérielle

AVC : Accident vasculaire cérébral

OMS : Organisation mondiale de la santé

TAS : Tension artérielle systolique

TAD : Tension artérielle diastolique

Mm hg : millimètres de mercure

IMC : indice de masse corporel

DASH : méthode alimentaire pour réduire la tension artérielle

EAL : bilan lipidique

HDL : lipoprotéine de haute densité

LDL : lipoprotéine de faible densité

ARA : antagoniste des récepteurs de l'angiotensine

IEC : inhibiteurs de l'enzyme de conversion

ECG : électrocardiogramme

HCTZ : Hydrochlorothiazide

## Liste des tableaux

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 1 : Classification de l'HTA -----                                     | 9  |
| Tableau 2 : Présentation des résultats par nombre de cas -----                | 18 |
| Tableau 3 : Prévalence de l'utilisation des médicaments selon la zone -----   | 18 |
| Tableau 4 : Répartition des médicaments antihypertenseurs selon la zone ----- | 19 |

## Liste des figures

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1 : Comment prendre sa tension -----                 | 8  |
| Figure 2 : Le système rénine-angiotensine-aldostérone ----- | 10 |
| Figure 3 : Facteur de risque -----                          | 11 |
| Figure 4 : Les organes touchés par l'HTA -----              | 13 |
| Figure 4 : Le régime de DASH -----                          | 16 |

# TABLE DES MATIERES

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Dédicace et remerciement.....              | 1  |
| Liste des abréviations.....                | 2  |
| Liste des tableaux.....                    | 3  |
| Liste des figures .....                    | 4  |
| Introduction.....                          | 6  |
| Chapitre 1 : Revue de la littérature ..... | 7  |
| Chapitre 2 : Méthodologie .....            | 17 |
| Chapitre 3 : Analyse des résultats .....   | 18 |
| Conclusion et recommandations .....        | 21 |
| Bibliographie et sitographie .....         | 22 |
| Annexes.....                               | 23 |

# INTRODUCTION

Dans un monde en constante évolution, les modes de vie des populations changent rapidement, entraînant des conséquences significatives sur la santé. L'urbanisation croissante, par exemple, a modifié les habitudes alimentaires et favorisé un mode de vie sédentaire. Les individus adoptent souvent des régimes riches en graisses saturées et en sodium, tout en réduisant leur niveau d'activité physique. Ces transformations sont exacerbées par des facteurs socio-économiques, tels que la pauvreté et l'accès limité à des soins de santé de qualité, créant un terrain fertile pour l'émergence de maladies chroniques.

Les maladies métaboliques, telles que le diabète et l'obésité, sont devenues des préoccupations majeures dans de nombreux pays, en particulier ceux à revenus faible et intermédiaire. Ces affections sont souvent interconnectées et peuvent entraîner des complications graves, affectant la qualité de vie des individus et augmentent les coûts des soins de santé. La sensibilisation à ces problématiques de santé est cruciale, car elle permet de mobiliser des ressources et d'engager des actions préventives.

Parallèlement, le rôle des facteurs psychologiques et comportementaux dans la santé physique ne peut être sous-estimé. Le stress, la dépression et l'anxiété peuvent influencer les comportements de santé, conduisant à des choix alimentaires malsains et à une inactivité physique accrue. Les systèmes de santé doivent s'adapter à ces défis émergents.

Dans ce contexte, l'HTA émerge comme un problème de santé publique majeur. Souvent le résultat d'une combinaison de facteurs de risque liés au mode de vie, à l'environnement et aux déterminants sociaux, l'HTA représente une menace sérieuse pour la santé, entraînant des complications graves telles que les maladies cardiovasculaires et les AVC. Comprendre l'épidémiologie de l'HTA est donc crucial pour élaborer des stratégies de prévention et de prise en charge adaptées aux spécificités de chaque population.

# Chapitre 1

## Revue de la littérature

### Définition de l'HTA

L'hypertension artérielle (HTA) est une maladie chronique caractérisée par une pression trop élevée du sang contre les parois des artères. L'OMS considère qu'une pression artérielle est élevée lorsque :

- La pression artérielle systolique (PAS) est  $\geq 140\text{mmHG}$
- La pression artérielle diastolique (PAD) est  $\geq 90\text{mmHG}$

L'OMS définit le sujet âgé comme celui qui a au moins 65 ans.

### Épidémiologie de l'HTA

. **Prévalence mondiale** : Environ 1,13 milliard de personnes souffrent d'HTA.

. **Variabilité régionale** :

- . En Afrique, la prévalence peut atteindre 46% chez les adultes.
- . En Europe, environ 30-40 % des adultes sont hypertendus.

. **Point épidémiologiques clés de l'OMS** :

- . 7,5 millions de décès par an dus à l'HTA
- . Facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires, les AVC et les maladies rénales.

### Définition de la pression artérielle :

La pression artérielle est la force que le sang exerce sur les parois des artères, mesurée en millimètres de mercure (mm Hg).

Elle se compose de deux valeurs :

- . Pression systolique : maximale lors de la contraction du cœur.
- . Pression diastolique : minimale lorsque le cœur est au repos.

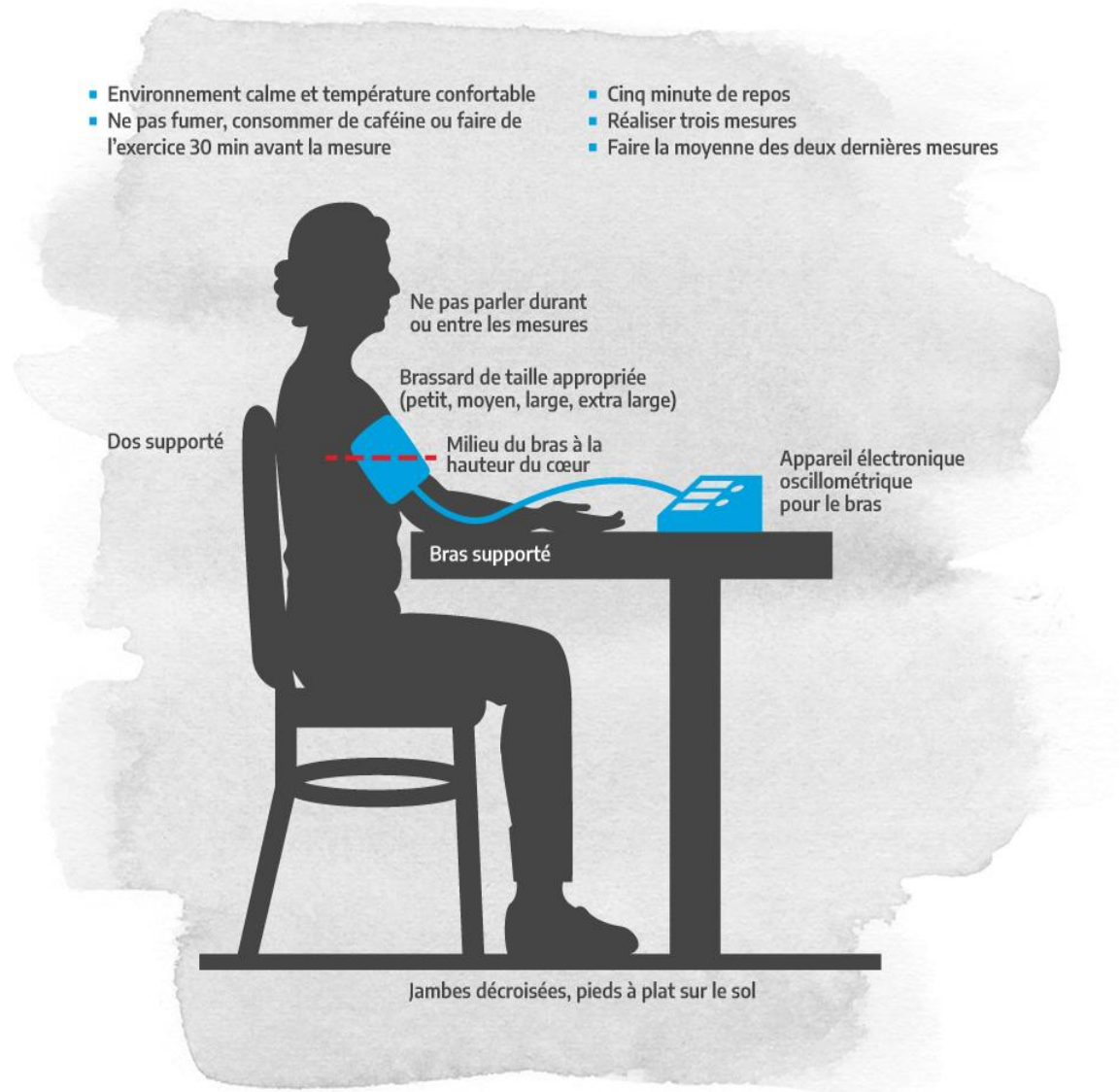
Une pression artérielle normale est généralement autour de 120/80 mm Hg. Elle est essentielle pour assurer la circulation sanguine et fournir oxygène et nutriments aux organes.

La pression artérielle est mesurée avec un sphygmomanomètre, souvent utilisé dans les cabinets médicaux. Elle peut être également mesurée à domicile avec des appareils automatiques. Pour obtenir une mesure fiable de la pression artérielle, il est essentiel de respecter un protocole précis, car de nombreux facteurs peuvent fausser les résultats. Pour une mesure de tension artérielle correcte, placez un brassard autour du bras, juste au-dessus du



coude. Assurez-vous que le patient est assis et reposé pendant 5 minutes. Éviter toute consommation de café, de tabac ou d'exercice 30 minutes avant de prendre la mesure.

Le dos et le bras soutenu au niveau du cœur. Utilisez un brassard de taille appropriée, placé juste au-dessus du coude. Il est conseillé de prendre au moins deux à trois mesures à intervalles de quelques minutes pour obtenir une moyenne fiable.



## Classification de l'HTA

La classification de l'HTA selon l'OMS, incluant les types primaire et secondaire, ainsi que l'HTA résistante :

- Hypertension primaire ou essentielle : aucune cause identifiable et représente environ 90-95% des cas.
- Hypertension secondaire : résulte d'une condition médicale sous-jacente identifiable.
- Hypertension résistante : HTA qui reste élevée malgré le traitement avec au moins 3 antihypertenseurs, dont un diurétique.

AUTRES TYPES :

- Hypertension de la blouse blanche : élévation de la pression artérielle mesurée en consultation médicale, sans hypertension persistante en dehors de ce contexte.
- Hypertension masquée : pression artérielle normale lors des consultations médicales, mais élevée en dehors de celle-ci.

### Tableau 1 :

Tableau présentant la classification de l'hypertension artérielle (mm Hg) (OMS & SIHA', 1999)

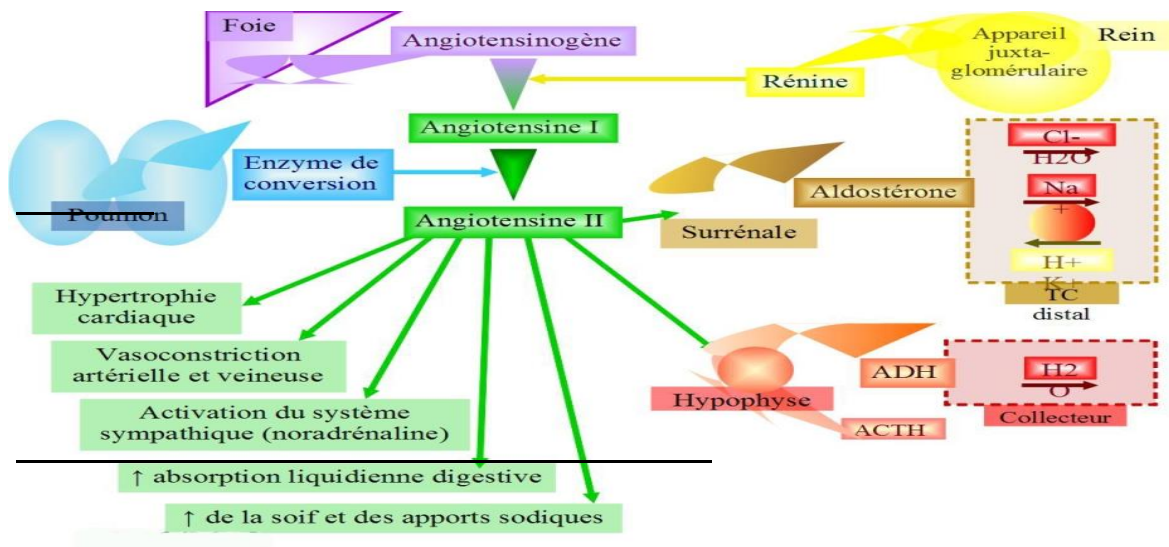
| Catégorie                                 | Systolique<br>(mm Hg) |       | Diastolique<br>(mm Hg) |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------|
| <b>Optimale</b>                           | <120                  | Et    | <80                    |
| <b>Normale</b>                            | <130                  | et/ou | <85                    |
| <b>Normale élevée</b>                     | 130-139               | et/ou | 85-89                  |
| <b>Grade 1</b>                            | 140-159               | et/ou | 90-99                  |
| <b>Grade 2</b>                            | 160-179               | et/ou | 100-109                |
| <b>Grade 3</b>                            | ≥180                  | et/ou | ≥110                   |
| <b>Hypertension<br/>systolique isolée</b> | ≥140                  | Et    | <90                    |

## PHYSIOPATHOLOGIE DE L'HTA

L'HTA est une condition où la pression dans les artères est constamment élevée. Cette élévation résulte de plusieurs mécanismes interconnectés :

- Résistance vasculaire périphérique : la constriction des vaisseaux sanguins, souvent en raison d'une hyperactivité du système nerveux sympathique, augmente la résistance à l'écoulement du sang. Cela élève la pression artérielle, car le cœur doit travailler plus fort pour faire circuler le sang.
- Système rénine-angiotensine-aldostérone (SRRA) : lorsque la pression artérielle baisse, les reins libèrent de la rénine, qui transforme l'angiotensine du foie en angiotensine I. Cette dernière est convertie en

angiotensine II dans les poumons, entraînant une vasoconstriction et une augmentation de la soif. L'angiotensine II stimule également la sécrétion d'aldostérone par les glandes surrénales. L'aldostérone favorise la réabsorption de sodium et d'eau dans les reins ce qui augmentent le volume sanguin.



- Dysfonction endothéliale : l'endothélium produit des substances régulatrices comme le monoxyde d'azote (vasodilatateur) et l'endothéline (vasoconstricteur). Une dysfonction endothéliale, souvent liée à des facteurs de risque (diabète, hyperlipidémie), peut réduire la capacité des vaisseaux à se dilater, contribuant à l'HTA.
- Régulation néphrotique : les reins régulent le volume sanguin en filtrant le sodium et l'eau. Une rétention excessive de sodium augmente le volume sanguin. Cela contribue à une pression artérielle plus élevée dans le système vasculaire.
- Facteurs hormones et métaboliques : hormones comme l'adrénaline et la noradrénaline augmentent la fréquence cardiaque et la contractilité du cœur, ce qui élève la pression artérielle. Une exposition prolongée à ces hormones peut mener à une hypertension chronique.

## Les facteurs de risque

Facteurs de risque modifiables : Ce sont des facteurs sur lesquels on peut agir, par des changements de mode de vie, traitement ou prévention :

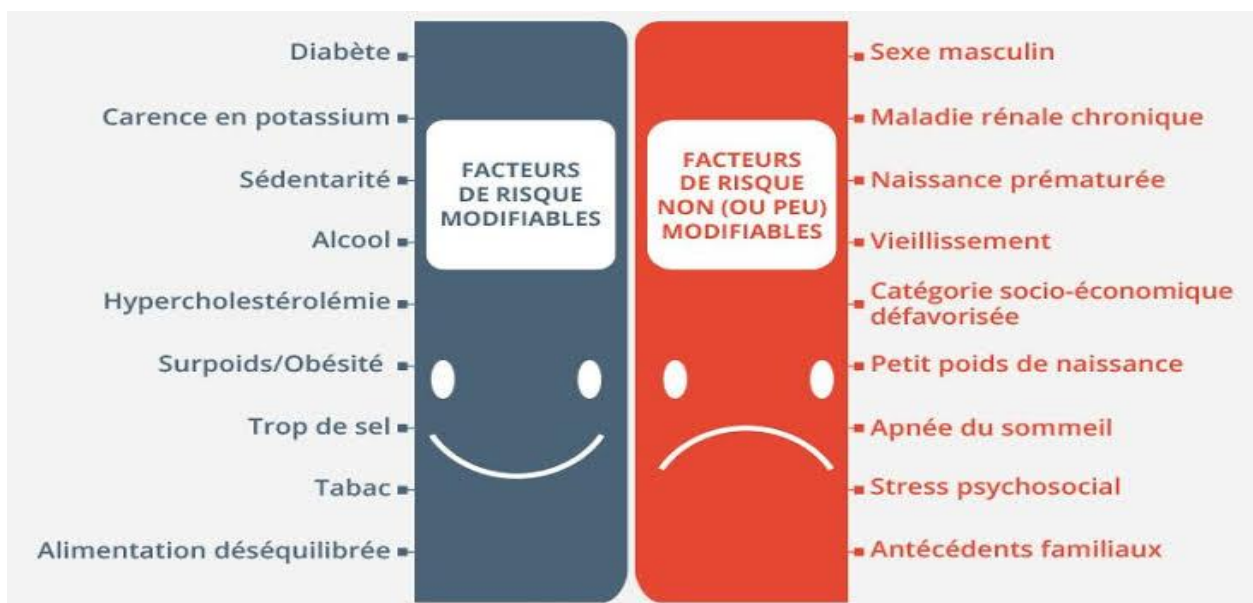
- **Diabète** : Maladie chronique liée à une mauvaise régulation du sucre dans le sang. Peut-être contrôlé par alimentation, exercice et médicaments.
- **Carence en potassium** : Un faible taux de potassium peut augmenter la pression artérielle. On peut corriger cela par une alimentation adaptée.
- **Sédentarité** : Manque d'activité physique, facteur aggravant pour le cœur et la pression artérielle. L'exercice régulier est bénéfique.
- **Alcool** : Consommation excessive augmente la pression artérielle et les risques cardiovasculaires. Réduire l'alcool est conseillé.
- **Hypercholestérolémie** : Taux élevé de cholestérol dans le sang, facteur de maladies cardiovasculaires. Peut-être contrôlé par régime, exercice et médicaments.

- Surpoids/Obésité : Excès de poids qui augmente la charge sur le cœur et la pression artérielle. Perdre du poids réduit ces risques.
- Trop de sel : L'excès de sel dans l'alimentation favorise l'hypertension. Diminuer le sel aide à contrôler la pression artérielle.
- Tabac : Fumer endommage les vaisseaux sanguins et augmente la pression artérielle. Arrêter de fumer réduit ce risque.
- Alimentation déséquilibrée : Une mauvaise alimentation (trop grasse, sucrée, salée) peut augmenter les risques cardiovasculaires. Une alimentation saine est préventive.

Facteurs de risque non (ou peu) modifiables : Ce sont des facteurs sur lesquels on ne peut pas ou difficilement agir :

Sexe masculin : Les hommes ont un risque plus élevé de certaines maladies cardiovasculaires que les femmes.

- Maladie rénale chronique : Maladie des reins qui affecte la pression artérielle, difficile à modifier.
- Naissance prématurée : Être né prématurément expose à certains risques de santé à long terme.
- Vieillessement : Avec l'âge, les risques cardiovasculaires augmentent naturellement.
- Catégorie socio-économique défavorisée : Facteur lié aux conditions de vie, accès aux soins, stress, difficile à changer rapidement.
- Petit poids de naissance : Un faible poids à la naissance est associé à un risque accru ultérieur.
- Apnée du sommeil : Trouble respiratoire pendant le sommeil, souvent héréditaire ou lié à la morphologie.
- Stress psychosocial : Stress lié à l'environnement social ou professionnel, difficile à éliminer totalement.
- Antécédents familiaux : Hérité, présence de maladies dans la famille qui augmentent le risque.



## La symptomatologie de l'HTA

L'HTA est souvent appelée **le tueur silencieux** car elle ne provoque généralement aucun symptôme pendant de nombreuses années. Le plus souvent, elle est découverte par hasard lors d'une consultation médicale systématique.

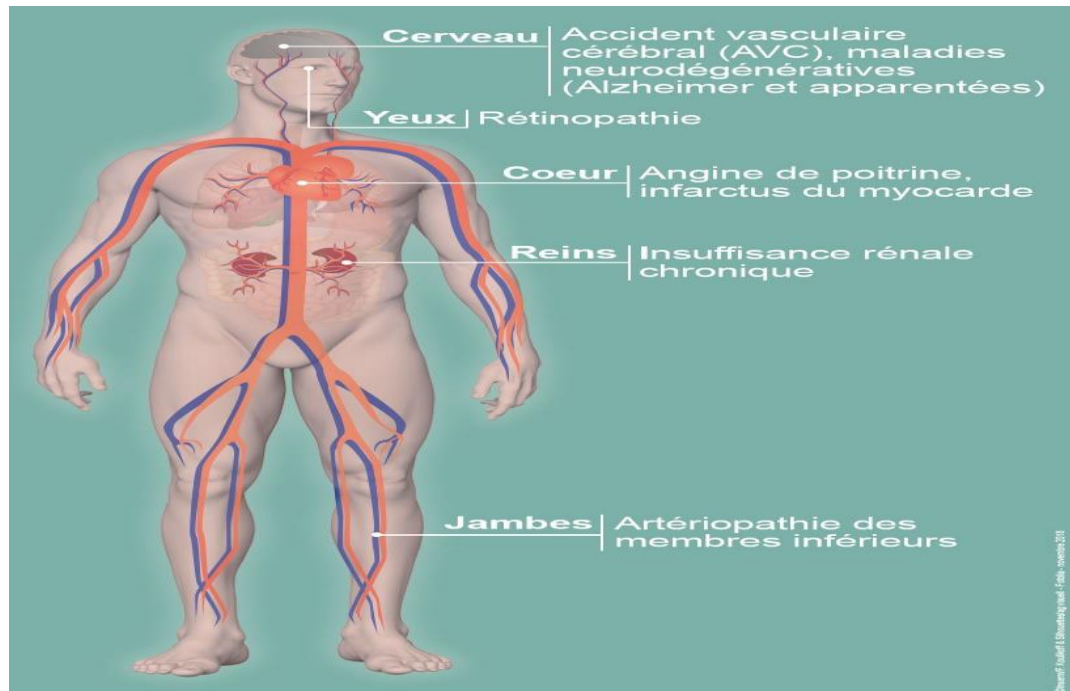
Signe évocateur :

- Maux de tête
- Bourdonnements ou sifflements d'oreille
- Trouble de la vision
- Vertiges
- Saignement de nez

## Les organes touchés par l'HTA

L'HTA affecte plusieurs organes vitaux du corps humain. L'HTA a un impact majeur sur le cerveau. Une pression artérielle élevée peut endommager les vaisseaux sanguins, augmentant le risque d'AVC. Ces AVC peut être ischémiques, dus à une obstruction, ou hémorragiques, causés par la rupture de vaisseaux. Ce qui peut également contribuer à des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Dans les yeux, l'HTA peut entraîner une rétinopathie, provoquant des saignements et une perte de vision, avec un risque de cécité si non traitée. Le cœur subit une surcharge de travail, ce qui peut entraîner une hypertrophie ventriculaire gauche, augmentant les risques d'angine, d'infarctus et d'insuffisance cardiaque. Les reins, essentiels pour filtrer les déchets sanguins, peuvent développer une insuffisance rénale chronique en raison de dommages causés par l'HTA, aggravant d'autres pathologies rénales. L'HTA peut provoquer une artériopathie des membres inférieurs, réduisant le flux sanguin et entraînant des douleurs, des ulcères ou des gangrènes.

## Tableau 3 : les organes touchés par l'HTA



## Diagnostic de l'HTA

Le diagnostic de l'HTA repose sur la constatation d'une pression artérielle élevée de manière permanente.

Selon la haute autorité de santé (HAS), le diagnostic est confirmé si les chiffres dépassent les seuils suivants :

- En cabinet médical :  $\geq 140/90$  mm HG, mesurés lors de plusieurs consultations.
- En dehors du cabinet : Auto mesure tensionnelle (AMT)  $\geq 135/85$  mm HG. Elle suit souvent la règle des 3' (3 mesures le matin et 3 mesure le soir, pendant 3 jours de suite).
- L'auto mesure : le patient utilise son propre tensiomètre à bras à domicile, au repos.
- Diagnostic confirmé si moyenne  $\geq 135/85$  mm HG.

Une fois le diagnostic posé, un bilan complémentaire est systématiquement réalisé pour évaluer le retentissement de l'HTA et les risques associés :

- Analyses de sang : Créatinine (fonction rénale), glycémie à jeun (recherche de diabète), cholestérol et potassium.
- Analyse d'urine : recherche de protéines (albuminurie)
- Bilan lipidique(EAL) : dosage du cholestérol (HDL, LDL, total) et des triglycérides.
- Cœur : ECG de repos systématique (recherche d'hypertrophie ventriculaire ou troubles du rythme).
- Clinique : mesure du tour de taille, recherche d'hypotension orthostatique (mesure debout après 1 et 3 minutes).

Le médecin doit systématiquement :

1. vérifier la tension aux deux bras lors de la première consultation
2. Dépister les souffles vasculaires (carotides, aorte abdominale, artères rénales).
3. Évaluer les fonctions cognitive via le test MMSE chez les patients de 75 ans et plus.

# Traitement de l'HTA

La prise en charge de l'HTA repose sur deux axes :

1. Les mesures hygiéno-diététiques
2. Le traitement médicamenteux

1. Les mesures hygiéno-diététiques : ses mesures sont mises en place avec le patient, telles que : la pratique d'une activité physique modérée (au moins 30 minutes par jour), une modération en apports en sel et de la consommation d'alcool, une régulation du poids (si nécessaire), un équilibre du régime alimentaire, l'arrêt de la consommation du tabac. Les mesures hygiéno-diététiques permettent de contrôler et de réguler efficacement la pression artérielle dans le but de maintenir à des valeurs inférieures à 140/90 mm HG et ainsi de diminuer le risque de conséquences cardiovasculaires.
2. Le traitement médicamenteux : le traitement antihypertenseur a pour objectif de ramener la tension artérielle à des valeurs tensionnelles inférieures à 140/90 mm Hg chez le sujet hypertendu n'ayant aucun facteur de risque de risque associé, et inférieure à 130/80 mm Hg chez le patient hypertendu présentant des risques tels que le diabète ou une hypercholestérolémie.

L'hypertension artérielle peut être corrigée par un traitement antihypertenseur en monothérapie ou en associant du fait de l'existence plusieurs classes thérapeutiques dont le mode d'action est différent.

Les différentes classes thérapeutiques d'antihypertenseurs sont :

1. Les diurétiques thiazidiques : qui agissent sur les reins et favorise l'élimination de l'eau et du sel (l'hydrochlorothiazide, Esidrex).
2. Les bêtabloquants : qui ralentissent la fréquence cardiaque et limitent l'intensité de la pression sanguine sur les parois des artères. (bisoprolol, métoprolol).
3. Les inhibiteurs calciques : qui favorisent la vasodilatation (relâchement des artères) et donc la baisse de la pression artérielle. (amlodipine, félodipine).
4. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) et les inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine II (ARA2) : qui limitent l'action d'hormones hypertensives (rénine et angiotensine) exemple IEC (énalapril, ramipril) ARAII (losartan, valsartan).
5. Les inhibiteurs des alpharécepteurs : qui agissent sur la tension artérielle en diminuant la contraction des vaisseaux. Ils sont majoritairement en dernière intention. Lorsqu'au moins deux autres traitements ont été essayés sans succès.

# Complications de l'HTA

1. Complication cardiaques : le surcroît de travail imposé au cœur du fait de l'augmentation de la pression artérielle entraîne une hypertrophie ventriculaire gauche pouvant être détecté par électrocardiographie ou échographie cardiaque. Infarctus du myocarde ; l'HTA favorise l'athérosclérose (durcissement des artères) ce qui peut boucher les artères coronaires.



2. Complication neurologique : un accident vasculaire cérébral hémorragique, une rupture d'un vaisseau d'un vaisseau cérébral ou ischémique par obstruction d'une artère par de l'athérome ou par un thrombus (conséquence de la rupture d'une plaque d'athérome).selon OMS, un hypertendu court 2 à 3 fois plus de risques de subir un accident vasculaire cérébral une encéphalopathie hypertensive (hypertension sévère, trouble de la conscience, rétinopathie avec œdème papillaire, crises convulsives).
3. Complication rénale : la néphroangiosclérose est pour sa part le retentissement rénal de l'hypertension artérielle mal contrôlée et elle de ce fait l'apparition d'une insuffisance rénale.

### Autre complications :

- Accidents gestationnels (c'est-à-dire chez la femme enceinte). L'HTA favorise les accidents gestationnels : éclampsie, mortalité, périnatale, etc.
- Complications vasculaires diverses : anévrisme, dissection aortique, artériopathie des membres inférieur.

## Prévention de l'HTA

La prévention de l'HTA repose sur une hygiène de vie saine, dont le pilier nutritionnel est le régime DASH (Dietary approaches to stop hypertension). Cette approche, validée par des organisations comme **l'american Heart Association et Hypertension Canada**, permet de réduire significativement la pression artérielle en quelques semaines.

Le régime DASH : ce régime privilégie les nutriments qui régulent la tension (potassium, magnésium, fibres) tout en limitant les éléments qui l'augmentent. Aliments à privilégier ; fruits et légumes 4 à 5 portion de chaque par jour. Céréales complète 6 à 8 portions (pain intégral, riz brun, avoine). Produits laitiers maigres 2 à 3 portions (yaourt, lait écrémé). Protéines maigres, noix et légumineuses. Aliments à limiter le sodium, le sucre, les graisses saturées.

L'alimentation seule ne suffit pas toujours ; elle doit s'intégrer dans un changement global de mode de vie : Activités physiques régulière : pratiquer au moins 30 minutes de marche rapide. Gestion du poids ; maintenir une IMC sain, car la perte de poids est directement liée à la baisse de la pression artérielle. Modération de l'alcool et du tabac : cesser de fumer et limiter l'alcool, qui sont des facteurs de risque majeurs.



# Régime DASH pour une tension artérielle saine

Suivez ces directives DASH  
(Dietary Approaches to Stop Hypertension)  
pour une alimentation plus saine et plus équilibrée



## **Chapitre 2**

### **Méthodologie**

L'objectif de cette étude est d'évaluer la prévalence de l'hypertension artérielle dans deux (2) zones spécifiques (Carradeux et Delmas 60). Il s'agit d'une étude épidémiologique quantitative, descriptive et transversal visant à analyser la fréquence de l'hypertension artérielle dans la population étudiée.

La population cible est constituée d'adultes âgés de 40 ans et plus, résidant dans les zones de Carradeux et Delmas 60. L'étude a porté sur un échantillon de 27 participants, un échantillonnage de convenance a été utilisé.

Les participants ont été recrutés parmi les personnes rencontrées dans les zones d'étude, répondant aux critères d'âge et ayant accepté volontairement de participer.

Critères d'inclusion :

Être âgé de 40 ans ou plus

Être résident permanent dans l'une des zones d'étude

Avoir donné un consentement libre et éclairé

Critères d'exclusion :

Incapacité à comprendre les instructions

Incapacité à donner un consentement éclairé

Femme enceinte

Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire structuré administré lors de visites à domicile.

La pression artérielle a été mesurée à l'aide de tensiomètre électronique et manuel.

Trois mesures ont été effectuées chez chaque participant

Un intervalle de 2 minutes a été respecté entre chaque mesure

Les mesures ont été réalisées après un repos de 5 minutes

Les données collectées ont été saisies et analysées à l'aide de Microsoft Word.

La prévalence de l'hypertension artérielle a été calculée dans chaque zone. Les résultats ont été présentés sous forme de fréquence et pourcentage. Le consentement libre et éclairé a été obtenu auprès de chaque participant avant la collecte des données. L'anonymat et la confidentialité des informations ont été strictement respectés, les données recueillies ont été utilisées uniquement à des fins scientifiques et académiques.

## Chapitre 3 : analyse des résultats

**Présentation des résultats des nombres de cas :**

**Tableau 2**

| ZONE             | Nombre de participants | CAS d'HTA | Prévalence |
|------------------|------------------------|-----------|------------|
| <b>Caradeux</b>  | 15                     | 8         | 53.3%      |
| <b>Delmas 60</b> | 12                     | 7         | 58.3%      |
| <b>Total</b>     | 27                     | 15        | 55.5%      |

**Prévalence de l'utilisation des médicaments selon la zone :**

**Tableau 3**

| ZONE             | Sous médicament | Non Sous médicament | Nombre de participant | Prévalence |
|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|------------|
| <b>Caradeux</b>  | 3               | 2                   | 5                     | 60%        |
| <b>Delmas 60</b> | 5               | 2                   | 7                     | 71.4%      |
| <b>Total</b>     | 8               | 4                   | 12                    | 66.7%      |

## Répartition des médicaments anti hypertenseurs selon la zone :

**Tableau 4**

| Zone      | Classe de médicaments    | Nom du médicament | Posologie (mg/jour) |
|-----------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Caradeux  | Inhibiteurs calciques    | Amlodipine        | 10 mg               |
|           | IEC                      | Énalapril         | 10 mg               |
|           | IEC                      | Énalapril         | 10 mg               |
| Delmas 60 | Inhibiteurs calciques    | Amlodipine        | 5 mg                |
|           | Diurétiques thiazidiques | HCTZ              | 25 mg               |
|           | IEC                      | Énalapril         | 10 mg               |
|           | IEC                      | Lisinopril        | 10 mg               |
|           | Diurétiques thiazidiques | HCTZ              | 12.5 mg             |

## Interprétation des résultats

Le tableau présente les données des participants répartis en 2 zones (Caradeux et Delmas 60) le nombre total des participants est 27 avec 15 participants dans la zone de Caradeux et 12 dans la zone de Delmas 60.

Concernant les cas d'HTA on dénombre 8 cas d'HTA dans la zone de Caradeux et 7 dans la zone de Delmas 60 cela présente pour Caradeux 8 cas sur 15 soit environ 53.3% pour Delmas 60, 7 cas sur 12 soit environ 58.3%

L'étude montre que la prévalence de l'utilisation des médicaments antihypertenseurs est globalement élevée (66,7 %), avec une proportion plus importante à Delmas 60 (71,4 %) qu'à Caradeux (60 %). Cela suggère une meilleure prise en charge ou un accès plus fréquent au traitement dans cette zone.

Par ailleurs, les classes de médicaments les plus utilisées sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), suivis des inhibiteurs calciques et des diurétiques thiazidiques. Les médicaments les plus prescrits sont l'énalapril, l'amlodipine et l'hydrochlorothiazide, avec des posologies variables selon les patients.

### Discussions

Les résultats montrent que plus de la moitié des participants dans chaque zone souffrent d'HTA. Ce qui suggère une problématique importante dans ces populations. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette prévalence élevée :

- Facteurs environnementaux : alimentation, stress, conditions de vie
- Facteurs socio-économiques : accès limités aux soins, faible niveau d'éducation sanitaire.

Les résultats de cette étude mettent en évidence une utilisation élevée des traitements dans la prise en charge de l'hypertension artérielle, bien qu'elle demeure insuffisante. Une meilleure couverture thérapeutique a été observée à Delmas 60 comparativement à Caradeux, suggérant des disparités liées à l'accès aux soins, à la disponibilité des médicaments et au niveau de sensibilisation des populations.

Par ailleurs, l'absence de traitement chez une proportion non négligeable de participants constitue un facteur de risque important de complications. La prédominance des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, associée à l'utilisation d'autres classes comme les inhibiteurs calciques et les diurétiques, reflète une prise en charge globalement conforme aux pratiques thérapeutiques recommandées.

Toutefois, les limites méthodologiques, notamment la petite taille de l'échantillon et le mode d'échantillonnage, restreignent la portée des résultats. Malgré cela, cette étude souligne la nécessité de renforcer les actions de dépistage, d'éducation sanitaire et d'amélioration de l'accès aux traitements afin d'optimiser le contrôle de l'hypertension artérielle dans les zones étudiées..

## **Conclusion et recommandation**

L'HTA est un problème de santé publique majeur qui affecte un nombre croissant de personnes à travers le monde. Cette étude a révélé que la prévalence de l'HTA varie considérablement selon les facteurs socio-économiques et environnementaux. Les résultats montrent que les populations vulnérables, souvent avec un accès limité aux soins de santé, sont particulièrement touchées. L'HTA peut entraîner des complications graves, comme les maladies cardiovasculaires et les AVC, ce qui souligne l'importance d'une gestion proactive. En somme, il est essentiel d'adopter une approche intégrée pour sensibiliser, dépister et traiter cette condition afin d'améliorer la santé globale des populations.

### **RECOMMANDATIONS**

1. Sensibilisation et éducation
2. Accès aux soins de santé
3. Interventions communautaire

## Bibliographies et sitographies

Inserm. Hypertension artérielle [internet]. [Cité le 02 mars 2026] publié le 05/07/2017 .  
Disponible sur <https://www.inserm.fr/dossier/hypertension-arterielle-hta/>

Société française de cardiologie Hypertension artérielle de l'adulte et de l'enfant. [Internet] .  
[Cité le 28 février 2026] publié le 07/11/2024. Disponible  
<https://www.sfc cardio.fr/publication/chapitre-04-item-224-hypertension-arterielle-de-ladulte-et-de-lenfant/>

OMS Hypertension artérielle [internet] par l'oms [cité le 01 mars 2026] Disponible sur  
<https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>

FHADIMAC Complications de l'hypertension artérielle [internet] par Dr René Charles [cité le 05 mars 2026]. Disponible sur <https://fhadimac.org/index.php/fr/les-maladies/hypertension/complications-hypertension>

Santé sur le net. Hypertension artérielle [internet] par Charline D.[cité le 02 mars 2026].  
Disponible sur <https://www.sante-sur-le-net.com/maladies/cardiologie/hypertension-arterielle/> Dernière mise à jour [ cité le 08 juillet 2024]

## ANNEXE E : Questionnaire

| <b>PARTIE I : DONNÉES SOCIODEMOGRAPHIQUES</b>           |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Vous êtes                                            | 1. F                      2. M                                                                                  |
| 2. Quel âge avez-vous (en année) ?                      | .....                                                                                                           |
| 3. Quelle est votre situation conjugale ?               | 1. Célibataire (jamais marié (e))<br>2. Marié (e)<br>3. Divorcé<br>4. Séparé<br>5. Concubinage<br>6. Veuf/veuve |
| 4. Quel est le plus haut niveau que vous avez atteint ? | 1. Non alphabétisé<br>2. Primaire<br>3. Secondaire I<br>4. Secondaire II<br>5. Universitaire                    |
| 5. Dans quel milieu vivez-vous (majoritairement) ?      | 1. Rurale (village)<br>2. Semi-urbaine (petite- ville)<br>3. Urbaine (grande                                    |
| 6. Quel genre de travail faites-vous (occupation) ?     | 1. En activité professionnelle<br>2. En chômage<br>3. En formation                                              |



## Survenue/ complication de l'HTA

1. Souffrez- vous de l'HTA ?      OUI      NON
2. Si oui, cela fait déjà combien de temps (mois) .....
3. Avez-vous fait une complication de l'HTA ?    OUI    NON

Dans quelles circonstances avez-vous découvert votre statut HTA

|                            |     |     |
|----------------------------|-----|-----|
| a. À la suite d'un malaise | OUI | NON |
| b. Contrôle de routine     | OUI | NON |
| c. Autres                  | OUI | NON |